

Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°147 /MVE-BDBV/08/10/2026

Date du rapport : 08 octobre 2026 Date de publication : 09 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Évolution encourageante de la situation épidémiologique, avec 58 nouveaux cas confirmés de MVE, contre 59 la veille (−1,7 %) et 76 au 01 octobre 2026 (−23,7 %). Ces cas ont été notifiés au Nord-Kivu (30), en Ituri (20), dans la Tshopo (4), au Haut-Uélé (3) et au Bas-Uélé (1).
- Réduction significative des décès communautaires, passant de 26 la veille à 14 (−46,2 %), contre 19 au 01 octobre (−26,3 %). Au total, 33 décès ont été enregistrés, contre 37 la veille (−10,8 %), dont 19 dans les CTE, nécessitant le renforcement de la qualité des soins.
- Amélioration des performances de la riposte, avec 28 guérisons contre 23 la veille et 20 au 01 octobre, ainsi qu'une progression du suivi des contacts à 83,5 %, contre 80,0 % la veille et 81,3 % au 01 octobre.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
8845	4 275	48,3 %	950	2 320	83,5%

Provinces touchées et zones de santé touchées

7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi

65 Zones de santé touchées sur 167 (38,9%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au 08 octobre 2026, une évolution encourageante de la situation épidémiologique a été observée, avec 58 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), contre 59 la veille (−1,7 %) et 76 au 01 octobre 2026 (−23,7 %). Ces cas ont été notifiés dans cinq provinces : le Nord-Kivu (30), l'Ituri (20), la Tshopo (4), le Haut-Uélé (3) et le Bas-Uélé (1).

Une réduction significative des décès communautaires a également été enregistrée, avec 14 décès contre 26 la veille (−46,2 %) et 19 au 01 octobre (−26,3 %). Par ailleurs, 19 décès ont été rapportés dans les CTE, dont 9 en Ituri, 7 au Nord-Kivu, 2 dans la Tshopo et 1 au Haut-Uélé. Au total, 33 décès ont été enregistrés, contre 37 la veille (−10,8 %), malgré une augmentation des décès intra-CTE nécessitant le renforcement de la qualité de la prise en charge.

Les résultats de la prise en charge sont encourageants, avec 28 patients déclarés guéris, contre 23 la veille (+21,7 %) et 20 au 01 octobre (+40 %). Ces guérisons concernent l'Ituri (14), le Nord-Kivu (11) et le Haut-Uélé (3). Le suivi des contacts s'est également amélioré, atteignant 83,5 % contre 80,0 % la veille et 81,3 % au 01 octobre.

Au niveau national, le cumul atteint 8 845 cas confirmés et 4 275 décès, soit une létalité de 48,3 %, contre 8 787 cas et 4 242 décès la veille, et 8 376 cas et 4 042 décès au 01 octobre 2026. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 74,2 % des cas cumulés, tandis que le Nord-Kivu enregistre le plus grand nombre de nouveaux cas (30, soit 51,7 %).

Malgré ces progrès, l'extension géographique demeure préoccupante, avec la notification d'un premier cas dans la zone de santé de Dakwa, au Bas-Uélé. Depuis le début de l'épidémie, 65 zones de santé sur 167 (38,9 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées et 10 ZS ont atteint au moins 42 jours sans nouveau cas confirmé. Cinq ZS se situent entre 22 et 42 jours sans nouveau cas confirmé. Cette situation justifie la consolidation des acquis et le renforcement des interventions ciblées dans les foyers actifs et les nouvelles zones affectées.

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CAS ET DÉCÈS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET SITUATION DES ZONES DE SANTÉ, AU 08 OCTOBRE 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées*
Ituri	20	6 562	3 036	46,3 %	28/36 (77,8 %)	25/36
Nord-Kivu	30	1 841	1 054	57,3 %	17/34 (50,0 %)	15/34
Haut-Uélé	3	371	157	42,3 %	7/13 (53,8 %)	7/13
Tshopo	4	55	22	40,0 %	7/23 (30,4 %)	5/23
Sud-Kivu	0	3	1	33,3 %	1/34 (2,9 %)	0/34
Bas-Uélé	1	11	4	36,4 %	4/11 (36,4 %)	4/11
Sud-Ubangi	0	2	1	50,0 %	1/16 (6,3 %)	1/16
Total	**58**	**8 845**	**4 275**	**48,3 %**	**65/167 (38,9 %)**	**57 ZS dans 5 provinces**

ZS historiquement touchées : zones ayant enregistré au moins un cas confirmé depuis le début de l'épidémie. ZS actuellement affectées : zones n'ayant pas encore atteint 42 jours consécutifs sans nouveau cas confirmé, selon la définition opérationnelle retenue.

La situation épidémiologique montre une évolution encourageante, avec 58 nouveaux cas contre 59 la veille (−1,7 %) et 76 au 01 octobre (−23,7 %). L'Ituri enregistre une baisse de 29 à 20 cas, tandis que le Nord-Kivu connaît une hausse de 26 à 30 cas et concentre 51,7 % des nouvelles confirmations. La létalité nationale demeure stable à 48,3 %. Toutefois, l'extension de l'épidémie à la zone de santé de Dakwa, au Bas-Uélé, porte à 65 sur 167 (38,9 %) le nombre de zones de santé historiquement touchées, justifiant le renforcement des interventions ciblées.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 08 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6562**	**3036**	**46,3%**	**20**	**2**	**9**	**11**
Adja	12	1	8,3%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	213	47	22,1%	3			0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1798	599	33,3%	1		3	3
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	9	5	55,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	176	107	60,8%				0
Lita	295	149	50,5%			1	1
Logo	14	7	50,0%				0
Lolwa	35	9	25,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	41	17	41,5%				0
Mandima	217	108	49,8%	8	1	2	3
Mangala	366	157	42,9%				0
Mongbwalu	710	338	47,6%			1	1
Nia-Nia	317	178	56,2%	1		1	1

Nizi	802	289	36,0%	3			0
Nyankunde	133	39	29,3%	1			0
Rimba	14	5	35,7%				0
Rwampara	1121	388	34,6%	3	1	1	2
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	**1841**	**1054**	**57,3%**	**30**	**11**	**7**	**18**
Beni	430	283	65,8%	10	5	0	5
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	293	185	63,1%	4	1	2	3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	66	24	36,4%	3	1	1	2
Katwa	619	379	61,2%	6	2	3	5
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	37	20	54,1%				0
Lubero	23	11	47,8%				0
Mabalako	55	21	38,2%	3	1	0	1
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	36	11	30,6%				0
Musienene	141	69	48,9%	1	0	0	0
Mutwanga	20	4	20,0%				0
Oicha	37	18	48,6%	1	1	0	1
Vuhovi	39	12	30,8%	2		1	1
Haut-Uélé	**371**	**157**	**42,3%**	**3**	**0**	**1**	**1**
Boma Mangbetu	44	19	43,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	97	47	48,5%	2	0	1	1
Rungu	4	2	50,0%				0
Wamba	120	43	35,8%	1	0	0	0
Tshopo	**55**	**22**	**40,0%**	4	1	2	3
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	29	12	41,4%	2		1	1
Mangobo	10	7	70,0%	2	1	1	2
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**11**	**4**	**36,4%**	1	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%	1	0	0	0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0

Total	**8845**	**4275**	**48,3%**	**58**	**14**	**19**	**33**

La situation épidémiologique montre une évolution encourageante, avec 58 nouveaux cas contre 59 la veille (−1,7 %) et 76 au 01 octobre (−23,7 %). L'Ituri enregistre une baisse de 29 à 20 cas, tandis que le Nord-Kivu passe de 26 à 30 cas et concentre 51,7 % des nouvelles confirmations. Mandima (8 cas), Beni (10 cas) et Katwa (6 cas) demeurent les principaux foyers actifs. Les décès communautaires diminuent de 26 à 14 (−46,2 %), malgré 19 décès intra-CTE. La létalité nationale reste stable à 48,3 %. L'apparition d'un cas à Dakwa (Bas-Uélé) appelle au renforcement de la surveillance et des interventions ciblées.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 08 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	139	6	145	45	6	100	0	51	15
Bas Uélé	133	2	135	16	2	117	0	18	0
Ituri	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nord-Kivu	1 235	62	1297	129	62	1 106	0	191	99
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	143	2	145	10	0	133	2	10	0
Total Général	**1 650**	**72**	**1 722**	**200**	**70**	**1 456**	**2**	**270**	**114**

La surveillance demeure soutenue, avec 1 722 alertes reçues, dont 270 (15,7 %) validées comme cas suspects et toutes investiguées (100 %), traduisant une bonne réactivité des équipes. Le Nord-Kivu concentre 75,3 % des alertes et 70,7 % des suspects validés. Toutefois, seuls 114 suspects sur 270 (42,2 %) ont été transférés vers les CT/CTE, nécessitant le renforcement du référencement et du transport des malades.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

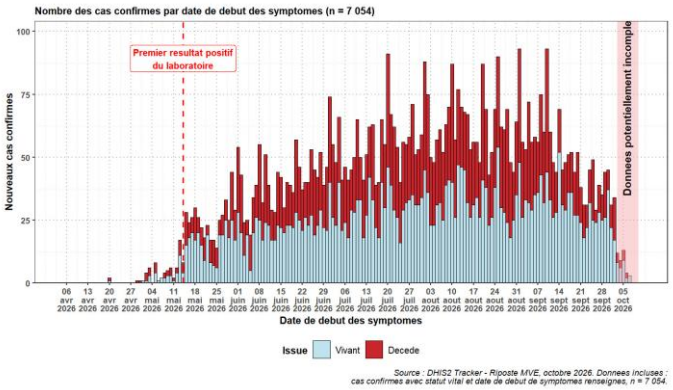
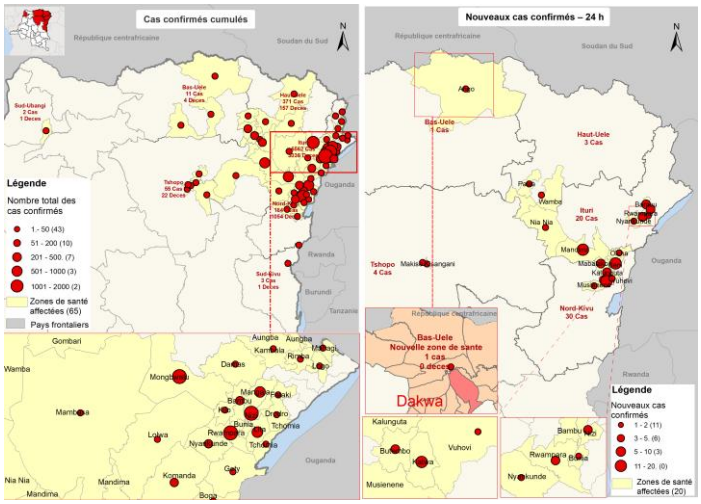


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Poursuite de l'appui technique, stratégique et opérationnel aux activités de riposte dans les provinces affectées, à travers les différents piliers techniques ;
- Tenue des réunions de coordination nationale et provinciale pour l'évaluation des performances, l'identification des gaps opérationnels et le suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
- Poursuite de la mission d'appui des experts nationaux dans la zone de santé de Mandima (Ituri), en vue de renforcer les capacités des équipes locales, la coordination des interventions et la maîtrise des chaînes de transmission ;
- Finalisation du préparatif de la mission d'accompagnement de proximité de l'Incident Manager (IM) au Nord-Kivu, afin d'évaluer les progrès réalisés et de renforcer l'engagement des autorités provinciales ;
- Renforcement des échanges avec les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers et les responsables provinciaux pour faciliter la mobilisation des ressources et la résolution des contraintes opérationnelles ;
- Suivi des interventions prioritaires dans les foyers actifs, particulièrement à Mandima, Beni, Butembo et Katwa, avec un accent sur la surveillance, la prise en charge, la prévention et le contrôle des infections et les enterrements dignes et sécurisés ;
- Poursuite du suivi des gaps opérationnels, de la disponibilité des intrants et de la redevabilité des intervenants à travers les mécanismes de coordination et les réunions interpiliers ;
- Renforcement de la collaboration interprovinciale entre l'Ituri et le Nord-Kivu pour améliorer la surveillance transfrontalière entre provinces, le partage d'informations et le suivi des mouvements de populations dans les zones à risque.

1.2. Défi majeur

Consolider les progrès réalisés, renforcer l'accompagnement opérationnel des foyers actifs et assurer le suivi rapproché des provinces affectées afin d'accélérer l'interruption des chaînes de transmission.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au **08 octobre 2026**, **1 722** alertes ont été rapportées dans quatre provinces. Toutes ont été vérifiées (**100,0 %),** dont **270 (15,6 %)** ont été validées comme cas suspects et **1 452 (84,3 %)** invalidées. Les **270** cas suspects ont tous été investigués (**100,0 %).** Parmi eux, **114 (42,2 %)** ont été transférés vers les CT/CTE

Parmi **29 140** contacts en cours de suivi, 24 337 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **83,5 %,** en hausse par rapport à la veille (**80,0 %)** mais inférieure au seuil requis de **95,0 %.** Par province, cette proportion était de **95,5 % (612/641) à la Tshopo, 92,5 % (172/186) au Bas-Uélé, 85,5 % (1 779/2 081) au Haut-Uélé, 83,9 % (9 038/10 772**) en Ituri et **82,4 %** (12 736/15 460) au Nord-Kivu ; seule la Tshopo atteint le seuil **de 95 %.**

2.1.2. Défi majeur

Renforcer le suivi des contacts dans les principaux foyers actifs, améliorer le transfert rapide des cas suspects vers les CT/CTE et garantir la complétude des données pour accélérer l'interruption des chaînes de transmission.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Six (6) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC repris au Tableau 4 le 08 octobre : quatre (4) en Ituri et deux (2) au Nord-Kivu, aucune à la Tshopo ; les 3 cas suspects validés ont tous été investigués dans les délais. En Ituri, l'alerte du PoC Iga Barrière (ZS de Nizi) a été invalidée après dépistage secondaire, celles de l'aéroport de Bunia et du PoC de Mudzi Bala (ZS de Bunia) ont été transférées respectivement au CTE Elikia et au CTE de Bunia, et un corps sans vie constaté au PoC DGRPI Nizi a été swabé par l'équipe EDS (résultat en attente).

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 08 octobre 2026				
Indicateurs	**Ituri**	**Nord-Kivu**	**Tshopo**	**Global**
Complétude des rapports	98,4% (60/61)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	98,0% (98/100)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	152 060	91 930	18 484	262 474
% des voyageurs screenés	98,2%	97,5%	98,6%	98,0%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,7%	97,5%	98,5%	97,7%
% des voyageurs sensibilisés	99,6%	97,5%	100,0%	98,9%
Nombre d'alertes notifiées	4	2	0	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	1	0	3
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	1	0	2
% des cas suspects transférés au CTE/CT	100,0%	100,0%	NA	100,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	100,0%	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	NA	100,0%

2.2.2. Défis

Assurer la continuité et l'efficacité de la surveillance sanitaire aux PoE/PoC, particulièrement sur les axes à forte mobilité entre l'Ituri et le Nord-Kivu, malgré les contraintes sécuritaires et logistiques, afin de garantir la détection précoce, l'investigation et le transfert rapide des cas suspects et de prévenir la propagation interprovinciale de la MVE.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 20 nouveaux résultats positifs** (18 vivants et 2 décès) sur 139 échantillons reçus et analysés **(positivité : 14,4 %) ;**
- **Nord-Kivu : 30 nouveaux résultats positifs** (19 vivants et 11 décès) sur 180 échantillons reçus et analysés **(positivité : 16,7%) ;**
- **Haut-Uélé : 3 nouveaux résultats positifs (**2 vivants et 1 décès) **sur 24 échéntillons réçus et analysés (positivité : 12,5%) ;**
- **Tshopo : 4 nouveaux résultats positifs (3 sangs et 1) sur 14 échantillons reçus et analysés (positivité : 28,6%) ;**
- **Bas Uélé : 1 résultat positif** (1sangs) sur 33 reçus et analysés **(positivité : 3,0%).**

2.3.2. Défi majeur

Garantir la continuité et la rapidité du diagnostic biologique dans toutes les provinces affectées, particulièrement dans les foyers actifs et les nouvelles zones touchées, malgré les contraintes d'acheminement des échantillons, de disponibilité des intrants et de capacités opérationnelles des laboratoires, afin d'assurer la confirmation précoce des cas et l'orientation rapide des interventions de riposte.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri :** 12 rings ont été ouverts sur 23 (52,2 %), 17 ménages décontaminés sur 28 (60,7 %) et 7 FOSA décontaminées sur 7 (100 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 99 alertes EDS (dont 8 reports de la veille), 57 EDS ont été réalisés (57,6 %) et 62 corps swabés, avec 32 échecs (32,3 %) liés aux refus à Bambu, Mambasa, Mangala, Fataki et Mandima ; 10 reports restaient en fin de journée ;
- **Nord-Kivu :** 12 rings ont été ouverts sur 25 (48,0 %), avec un gap important à Katwa, 19 ESS décontaminées sur 25 (76,0 %) et 14 ménages sur 40 (35,0 %), aucun des ménages décontaminés n'ayant été doté en kits ; 21 évaluations PCI (score card) ont été réalisées dans 21 ESS avec un score moyen de 33 %. Sur 58 alertes EDS, 56 EDS ont été réalisés et 58 corps swabés sans échec, avec 51 reports au jour suivant ; la distribution de kits PCI/WASH dans 300 écoles a été lancée avec l'appui de CAUB/UNICEF et la formation de 14 équipes ECUMR a débuté à Vuhovi, Kyondo et Beni ;
- **Haut-Uélé :** 3 ESS (CTE de Pawa, CS Bachenze et CS Babonde) et 5 ménages ont été décontaminés dans la ZS de Pawa, 4 ESS ont été évalués (3 à Isiro et 1 à Boma Mangbetu) et 55 prestataires briefés (26 à Pawa, 14 à Wamba, 13 à Isiro et 2 à Boma Mangbetu) ; la famille d'un cas de l'AS Bachenze a refusé la décontamination de son ménage. Sur 4 alertes EDS, 4 EDS ont été réalisés (100 %) et 2 corps swabés, les 2 autres ayant déjà été prélevés au CT ;
- **Tshopo**. 13 ESS sur 13 ont été suivies dans 4 ZS avec le briefing de 137 prestataires sur les précautions standards, le triage et le screening ; le ménage d'un cas confirmé a été décontaminé à Mangobo (7 locaux et une latrine, avec incinération de 2 matelas) et 2 écoles ont été évaluées (EP La Colombe et EP Maendeleo). Depuis le début, 42 ESS sur 42 (100 %) et 32 ménages sur 35 (91,4 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures et 53 ESS sur 103 (51,5 %) ont reçu des kits PCI. Quant aux EDS, sur 4 reports et 3 alertes du CTE, 3 corps ont été swabés).

2.4.2. Défis

Améliorer la couverture et la qualité des interventions PCI/EDS dans les principaux foyers actifs, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, en réduisant les refus communautaires et les reports d'EDS, en renforçant l'ouverture des rings, la décontamination des ménages et des structures sanitaires ainsi que la disponibilité des kits PCI/WASH, afin de prévenir les infections secondaires et d'interrompre les chaînes de transmission.

2.4.3. Prise en charge holistique

2.4.4. Principales actions

- **En Ituri,** 58 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 102 sorties, dont 14 guérisons. 316 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits de 31,1 % : (316/1 015), dont 30 malades critiques ; 310 patients sur 334 (92,8 %) ont reçu un repas chaud et tous les enfants sous LNPE/SLM ont été pris en charge (12/12 au CTE, 6/6 à la crèche et 49/49 dans la communauté). Le cumul des guéris de la province atteint 1 850 ;
- **Au Nord-Kivu,** 100 nouvelles admissions (15 confirmés et 85 suspects) ont été enregistrées contre 96 sorties (78 non-cas, 11 guérisons et 7 décès). Au total, 523 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits de 91,8 % (325 patients aux lits des CTE/CT sur 354 lits), dont 3 malades critiques ; 149 patients sont pris en charge dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT, et 290 patients, 169 accompagnants et 408 PPL ont reçu des repas chauds ;
- **Au Haut-Uélé,** 12 nouvelles admissions (4 confirmés, dont 3 PPL, et 8 suspects) ont été enregistrées contre 17 sorties (11 non-cas, 3 guérisons et 3 décès). Au total, 71 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 51,4 % (71/138) ; le CTE normé d'Isiro a été officiellement remis par l'OMS à l'équipe de prise en charge, et 49 patients, 69 accompagnants et 69 PPL ont reçu des repas chauds ;
- **À la Tshopo,** 3 nouvelles admissions (1 confirmé et 2 suspects) ont été enregistrées contre 4 sorties (2 non-cas et 2 décès). Au total, 14 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 45,2 % (14/31) ; depuis le début, 424

personnes ont reçu le traitement expérimental, dont 37 cas confirmés, et 387 ont bénéficié de la prophylaxie post-exposition ;

- **Au Bas-Uélé,** 18 nouvelles admissions (le cas confirmé de la ZS de Dakwa, isolé à l'HGR de Dakwa, et 17 cas suspects) ont été enregistrées sans aucune sortie ; au total, 26 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée dans des centres de transit non normés (Bondo, Viadana, Buta, Dakwa et Ganga), la province ne disposant pas encore de CTE.

2.4.5. Défis

Renforcer et adapter les capacités d'isolement et de prise en charge holistique dans les provinces affectées, particulièrement au Nord-Kivu, où le taux d'occupation des lits atteint 91,8 % avec 149 patients pris en charge hors des CTE/CT, et au Bas-Uélé, dépourvu de CTE normé, tout en garantissant la qualité des soins, la disponibilité des intrants et la continuité de l'appui nutritionnel et psychosocial afin de réduire la mortalité et les risques de transmission nosocomiale.

2.5. Vaccination

2.5.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**le préenregistrement des PPL et TPL (leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards et chasseurs) s'est poursuivi, le cumul provincial atteignant 1 500 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (11,4 %), principalement à Buta (620 ; 21,6 %), à Ganga (273 ; 20,5 %) et à Viadana (243 ; 9,8 %) ; le stock provincial de vaccin Ervebo est épuisé (0 dose) ;
- **Au Haut-Uélé**, la vaccination des PPL et des agents de santé contre la MVE a été lancée dans l'AS de Mayogo par le Gouverneur de province, en présence de l'Incident Manager ;
- **En Ituri,** les outils de collecte des données de l'étude sur l'impact de l'épidémie de MVE sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive ont été prétestés.

2.5.2. Défis

Assurer la disponibilité continue des vaccins et accélérer la couverture vaccinale des populations prioritaires, particulièrement au Bas-Uélé, où seulement 11,4 % de la cible a été atteinte et où une rupture totale du stock de vaccin Ervebo est enregistrée, tout en consolidant le déploiement de la vaccination au Haut-Uélé et dans les autres zones à risque afin de prévenir de nouvelles chaînes de transmission.

2.6. Continuité des Soins

2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo,** l'évaluation du CS Tshopo 2 et du CS Salama a révélé l'absence de zone de triage effective dans les deux ESS ; au CS Bondeko, 14 agents sur 14 (100 %) sont vaccinés, 4 rendez-vous de CPS sur 16 attendus (25,0 %) ont été manqués et les 16 femmes enceintes attendues ont respecté leur rendez-vous de CPN ; le plan de travail PCSSE d'octobre et le plan de redressement du CS Ville ont été finalisés, et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis ;
- **Au Nord-Kivu,** un briefing sur la continuité des services de soins essentiels dans le contexte de la MVE a été organisé dans la ZS de Beni et l'HGR d'Oicha a été évalué ;
- **Au Bas-Uélé,** l'évaluation de l'HGR de Viadana montre une baisse de l'utilisation des services entre mai (7 009) et septembre 2026 (4 874), un taux d'occupation des lits de 20 % en septembre pour 70 % attendus, l'absence de zone de triage et de protection des PPL, et 16 PPL vaccinés sur 16**.**

2.6.2. Défi majeur

Garantir la continuité et l'utilisation des services de santé essentiels dans les zones affectées par la MVE, en corrigeant les insuffisances de triage et de protection des prestataires dans les établissements de soins, particulièrement à la Tshopo et au Bas-Uélé, et en inversant la baisse de fréquentation des structures sanitaires, afin de prévenir les infections nosocomiales et de maintenir l'accès aux soins de qualité pour les populations.

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri,** 21 666 visites à domicile ont touché 55 997 personnes ; 635 causeries éducatives ont réuni 9 859 personnes, 47 sensibilisations de masse 4 928 personnes, 99 débats communautaires 1 469 personnes et 7 plaidoyers 15 autorités et leaders ; 12 spots ont été diffusés sur 36 stations de radio et 9 émissions organisées. Au total, 470 alertes communautaires, dont 135 décès, ont été notifiées ; 43 feedbacks sur 79 (54,4 %) et 4 incidents sur 6 (66,7 %) ont été résolus dans les 48 heures, et 20 motards de Bunia et de Rwampara ont été briefés pour leur implication dans la SBC et la remontée des alertes. La complétude des rapports CREC n'est que de 36 % (10/28 ZS) ;
- **Au Bas-Uélé,** 158 visites à domicile ont touché 553 personnes à Ganga et à Viadana et 2 séances de sensibilisation de masse 672 personnes ; 12 alertes communautaires ont été notifiées, les 3 feedbacks reçus ont été résolus (100 %) et un plaidoyer a été mené auprès du chef de chefferie de Kipate pour la réinsertion communautaire des guéris ;
- **Au Nord-Kivu,** 877 personnes engagées sur « 4 75 attendues », avec une proportion annoncée de 18,5 %. Le dénominateur semble avoir été mal saisi. Pour obtenir 18,5 %, il devrait être proche de 4 740. Il faut confirmer la cible exacte dans le rapport provincial ;
- **Au Haut-Uélé,** 15 causeries éducatives, 3 séances de sensibilisation de masse et 122 visites à domicile ont touché 2 712 personnes à Isiro, Wamba et Watsa, et 42 RECO et membres CREC ont été formés ; 54 alertes communautaires, dont 6 décès, ont été notifiées dans 5 ZS et aucun des 13 feedbacks reçus n'a encore été résolu. La vaccination des PPL contre la MVE a été lancée par le Gouverneur de province en présence de l'Incident Manager.

2.7.2. Défi majeur

Renforcer l'engagement communautaire, la gestion rapide des rumeurs, feedbacks et incidents, ainsi que la redevabilité des équipes CREC, particulièrement en Ituri, où la complétude des rapports demeure faible (36 %), et au Haut-Uélé, où aucun des 13 feedbacks reçus n'a été résolu, tout en intensifiant l'implication des leaders communautaires et des personnes influentes pour améliorer l'adhésion aux mesures de riposte et prévenir les résistances communautaires.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **Nord-Kivu,** 23 sur 25 cas confirmés (92,0 %), 123 confirmés en cours de suivi, 75 nouveaux suspects et 376 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; les équipes ont accompagné 66 ménages pour les actions de santé publique et 23 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 25 (92,0 %), soutenu 30 PPL, réinséré 9 guéris, suivi 19 guéris sur 19 en communauté (100 %), 6 enfants sur 6 en crèche et 31 enfants sur 35 en communauté (88,6 %), réalisé la psychoéducation de 344 personnes (107 hommes, 166 femmes et 71 enfants) avec l'appui de l'UNICEF et annoncé 85 résultats, dont 26 positifs ; 7 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes (100 %) ;
- **En Ituri,** 16 sur 29 derniers cas confirmés (55,2 %), 83 confirmés en cours de suivi sur 118 (70,3 %), 18 nouveaux suspects sur 51 (35,3 %) et 95 suspects en cours de suivi sur 128 (74,2 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 282 accompagnants et 145 PPL, suivi 36 guéris sur 41 (87,8 %) en communauté et 15 enfants sur 15 en crèche, accompagné 14 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 17 (82,4 %), réinséré 8 guéris sur 13 (61,5 %) et annoncé 52 résultats, dont 16 positifs ; 77 enfants sont suivis ;
- **Au Haut-Uélé,** 4 nouveaux cas confirmés, 23 confirmés en cours de suivi, 7 nouveaux suspects et 26 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 58 accompagnants, 80 PPL (dont 25 membres de la coordination nationale), 10 enfants séparés en communauté et 10 membres de ménages, appuyé 3 EDS et annoncé 25 résultats, dont 4 positifs ; 25 kits de déchargement ont été remis aux guéris du CTE d'Isiro ;
- **Au Bas-Uélé,** 5 PPL, 6 membres de ménages et de la communauté et 1 contact ont été soutenus, 4 guéris déchargés sont suivis, 1 réticence a été levée et 3 résultats ont été annoncés (tous négatifs).

2.8.2. Défis

Renforcer la couverture et la continuité des interventions de santé mentale et de soutien psychosocial, particulièrement en Ituri, où l'accompagnement des nouveaux cas suspects (35,3 %) et la réinsertion communautaire des guéris (61,5 %) demeurent insuffisants, tout en garantissant le suivi psychosocial des enfants séparés et orphelins, des guéris, des familles affectées et des prestataires de première ligne, afin de réduire la stigmatisation, les résistances communautaires et les conséquences psychosociales de la MVE.

2.9. Sécurité

2.9.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, les équipes EDS ont été escortées pour l'enterrement de 2 cas confirmés au cimetière public de Bundji et de 6 cas confirmés du CT Matanda et de Katwa au cimetière de Manghera, ainsi que pour un décès communautaire au quartier Kitulu (AS Makisi), et les équipes PCI pour la décontamination du dispensaire Emmanuel Dalson (AS Tamende) et d'un ménage dans l'AS de Ngongolyo.

2.9.2. Défi majeur

Garantir la sécurité et la protection des équipes de riposte, particulièrement celles chargées des enterrements dignes et sécurisés (EDS) et de la prévention et du contrôle des infections (PCI) au Nord-Kivu, en assurant la disponibilité des escortes et la sécurisation des interventions dans les zones à risque, afin de prévenir les incidents sécuritaires, de maintenir la continuité des activités et de protéger les intervenants ainsi que les communautés.

2.10. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.10.1. Principales actions

- **En Ituri,**l 54 personnes (24 femmes, 12 hommes, 16 filles, dont 1 PVH, et 2 garçons) ont été sensibili-sées sur la PSEAH dans la ZS de Bunia (motards du parking Wewa, femmes allaitantes, per-sonnel et clients d'un salon de coiffure), et l'affichage des messages et la distribution des dé-pliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki.formation des formateurs sur la PSEAH a démarré dans la ZS de Bunia avec 27 participants (19 femmes et 8 hommes), et des sessions de formation ont réuni 61 enseignants et membres des comités de parents à Komanda (23 femmes et 38 hommes) ainsi que 22 membres des COPA, enseignants, leaders communautaires et associations féminines à Tchomia (8 femmes et 14 hommes). Les sensibilisations ont touché 3 502 élèves et personnels de cinq écoles d'Aru, 22 leaders communautaires et traditionnels à Lita et 8 peintres à Bunia, et 72 staffs ont été briefés et ont signé le code de bonne conduite. L'affichage des messages et la distribution des dépliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki ;
- **Au Nord-Kivu,** 20 volontaires points focaux PSEA/VBG (15 femmes et 5 hommes) ont été briefés à Beni avec l'appui du CICR, et 118 personnes ont été sensibilisées sur la PSEA et les voies de signalement (495555 et 151) à Beni (53, dont 20 membres des ECUMR), Butembo (11) et Katwa (54), avec la distribution de 15 dépliants ;
- **Au Bas-Uélé,** 67 RECO (28 femmes et 39 hommes) des AS Bambili et Agri-Uélé (ZS de Ganga) et 84 membres de la communauté (36 femmes et 48 hommes) d'écoles et d'églises de Buta ont été sensibilisés sur l'EAS dans le contexte de la MVE ;
- Au Haut-Uélé, 23 PPL et gardes-malades (6 hommes et 17 femmes) ont été sensibilisés au CH Gamba (Isiro), où 13 codes de bonne conduite ont été signés, ainsi que 30 acteurs des médias d'Isiro (24 hommes et 6 femmes) et 40 membres de la communauté au CS CECCA 16 à Wamba (17 hommes et 23 femmes) ; 6 ZS sur 7 (85,7 %) connaissent le mécanisme de signalement.

2.10.2. Défis

Au niveau national, 4 DPS sur 7 (57,1 %) ont rapporté leurs activités PSEA (Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé et Bas-Uélé) ; en Ituri, seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement, un seul partenaire (OMS) rapporte ses activités et les supports de sensibilisation

ainsi que les kits informatiques manquent ; au Nord-Kivu, la cartographie des mécanismes communautaires de gestion des plaintes n'est pas maîtrisée ; au Haut-Uélé et au Bas-Uélé, les moyens de transport et les supports de sensibilisation restent insuffisants.

2.11. Gestion des bases des données

2.11.1. Principales actions

- Poursuite de la collecte, de la centralisation, de la vérification et de la consolidation des données épidémiologiques et opérationnelles transmises par les différentes provinces affectées ;
- Renforcement du contrôle de qualité des données, notamment l'identification et la correction des doublons, des incohérences et des données manquantes dans les bases de surveillance, de laboratoire et de prise en charge ;
- Suivi de l'harmonisation des données entre les différents piliers techniques afin d'améliorer la fiabilité des indicateurs utilisés dans les SitRep et les tableaux de bord de pilotage ;
- Poursuite de l'appui technique aux équipes provinciales pour l'actualisation des bases de données et la transmission régulière des informations à la coordination nationale ;
- Nécessité de renforcer l'encadrement technique et la supervision de la gestion des données au Nord-Kivu, particulièrement dans les zones de santé de Beni, Butembo, Katwa et Musienene, afin de garantir la cohérence des notifications et d'éviter les doubles comptages des cas référés entre structures sanitaires.

2.11.2. Défi majeur

Garantir la qualité, l'exhaustivité et la disponibilité en temps réel des données de riposte, particulièrement au Nord-Kivu, où la gestion des notifications et des références entre zones de santé nécessite une harmonisation renforcée, afin de réduire les doublons, de fiabiliser les indicateurs épidémiologiques et d'assurer une prise de décision rapide et fondée sur des données validées.

MESSAGES CLES

- La transmission communautaire de la MVE demeure active en Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé, tandis que la Tshopo enregistre des cas sporadiques. Toutefois, une évolution encourageante est observée au niveau national, avec 58 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures, contre 59 la veille et 76 au 1er octobre 2026, soit une réduction de 23,7 % par rapport à cette dernière date. Cette tendance traduit des progrès à consolider, particulièrement dans les principaux foyers de transmission.
- La surveillance épidémiologique affiche des résultats encourageants, avec 100 % des cas suspects validés investigués et une amélioration du suivi des contacts, passé de 80,0 % à 83,5 %, soit un gain de 3,5 points de pourcentage. Malgré cette progression, la performance demeure inférieure à la cible opérationnelle de 95 %, nécessitant un renforcement du suivi dans les zones à transmission active.
- Consolider les acquis de la riposte en intensifiant la surveillance épidémiologique et le suivi des contacts, en renforçant les interventions PCI/EDS et l'engagement communautaire, particulièrement dans les foyers actifs de l'Ituri et du Nord-Kivu. Parallèlement, adapter les capacités de prise en charge aux besoins réels, notamment au Nord-Kivu où la pression sur les lits demeure élevée, et accélérer l'opérationnalisation de structures adaptées au Bas-Uélé, tout en garantissant la qualité et la continuité des soins.
- L'enjeu majeur reste de transformer les progrès observés en une réduction durable de la transmission communautaire, grâce à une coordination renforcée, une meilleure redevabilité des intervenants et un suivi rigoureux des interventions prioritaires.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.